

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Στο παρόν εδάφιο περιγράφεται μια σημαντική ομάδα φαρμάκων η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στη χρόνια θεραπευτική αγωγή της υπέρτασης (ΑΥ) (ειδικά στους ηλικιωμένους και στους μαύρους), στην περιφερική αγγειοπάθεια, στη θεραπεία των υπερκοιλιακών αρρυθμιών, στη νόσο των καρωτίδων και στην εγκυμοσύνη, αλλά **δεν έχει θέση στη θεραπεία της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας, οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.**

Οι αποκλειστές (αναστολείς) των διαύλων ασβεστίου (ΑΔΑ - CCBs) διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις **μη διυδροπυριδίνες** που περιλαμβάνουν τη Βεραπαμίλη και τη Διλτιαζέμη και στις **διυδροπυριδίνες** που περιλαμβάνουν τις ουσίες που φέρουν την κατάληξη «-διπίνη».

Οι μη διυδροπυριδίνες εμφανίζουν ανασταλτικές επιδράσεις στο κολπικό μυοκάρδιο και στον κολποκοιλιακό κόμβο, που έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την επιβράδυνση της καρδιακής αγωγιμότητας και της συσταλτικότητας. Αυτό ευοδώνει τη θεραπεία της ΑΥ, μειώνει τις απαιτήσεις σε οξυγόνο και βοηθά στον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού στις ταχυαρρυθμίες, έτσι η Διλτιαζέμη συνεπικουρεί στην αντιμετώπιση της στηθάγχης Prinzmetal ή εκ ψύχους.

Οι διυδροπυριδίνες, σε θεραπευτικές δόσεις, έχουν μικρή άμεση επίδραση στο μυοκάρδιο. Αντ' αυτού, προκαλούν αρτηριακή αγγειοδιαστολή (και των στεφανιαίων αγγείων), για αυτό κρίνονται χρήσιμες στην ΑΥ, στη σταθερή στηθάγχη, στον αγγειόσπασμο μετά από ενδοκράνια αιμορραγία (Νιμοδιπίνη), στη θεραπεία του φαινομένου Raynaud και στις ημικρανίες.

ΟΥΣΙΑ	ΣΚΕΥΑΣΜΑ	Ημερήσια δόση	t _{max}	Χρόνος Ημιζωής
Amlodipine	<i>Norvasc / Amlophen</i>	5-10 mg	6-12 h	35-40 h
Felodipine	<i>Plendil</i>	2,5-10 mg	2-7 h	10-15 h
Lacidipine	<i>Lacipil / Motens</i>	4 mg	3-5 h	10-15 h
Lercanidipine	<i>Lercadip</i>	10-20 mg	1,5-3 h	8-10 h
Manidipine	<i>Manyper</i>	5-20 mg	1-2 h	4-8 h
Nifedipine	<i>Adalat / Glopir</i>	30-120 mg	0,5-1 h	2-5 h
Nimodipine	<i>Nimotop / Befimat</i>	240 mg	0,5-2 h	5-10 h
Nitrendipine	<i>Nifecard / Lisba</i>	10-20 mg	2 h	8-14 h
Verapamil	<i>Isoptin</i>	80-240 mg	1-2 h	3-6 h
Diltiazem	<i>Tildiem / Dipen</i>	60-180 mg	1-2 h	3,5-10 h

Οι μη διυδροπυριδίνες αντενδείκνυνται σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (LVEF ≤ 40%), σε 2^ο και 3^ο βαθμού (πλήρη) κολποκοιλιακό αποκλεισμό και επί συνδρόμου νοσούντος φλεβοκόμβου (SSS) – εκτός φυσικά των ασθενών που φέρουν μόνιμο βηματοδότη – λόγω της πιθανότητας πρόκλησης σοβαρής βραδυαρρυθμίας, βαριάς υπότασης και επιδείνωσης της καρδιακής παροχής. Περιφερικό οίδημα (ειδικά των κάτω άκρων) μπορεί να εμφανιστεί εντός 2-4 εβδομάδων από την έναρξη της θεραπείας με τους ΑΔΑ - CCBs. Χρησιμοποιούνται με προσοχή επί νεφρικής και ηπατικής δυσλειτουργίας.

Οι μη διυδροπυριδίνες σε υπερδοσολογία – εκτός της σοβαρής υπότασης (έως shock) και των βραδυαρρυθμιών – μπορεί να προκαλέσουν ζάλη, φωταψίες, επίταση χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας, έξαψη, κεφαλαλγία και δυσκοιλιότητα. Οι διυδροπυριδίνες σε ήπια έως μέτρια υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσουν αντανάκλαστική ταχυκαρδία. Ωστόσο, επί σοβαρής υπερδοσολογίας μπορεί να υπάρξει απώλεια της εκλεκτικότητας των υποδοχέων η οποία οδηγεί σε σοβαρή βραδυκαρδία. Η υπεργλυκαιμία θεωρείται σημαντικός προγνωστικός δείκτης της σοβαρότητας της τοξικότητας από τους CCBs. Στα κύτταρα των βήτα νησίδων του παγκρέατος η απελευθέρωση της ινσουλίνης εξαρτάται από την εισροή του ασβεστίου μέσω των ειδικών διαύλων ασβεστίου τύπου -L. Έτσι, επί υπερδοσολογίας από CCBs, παρατηρείται μείωση της απελευθέρωσης της ινσουλίνης και επακόλουθη υπεργλυκαιμία. Σπανίως δε, σε ασθενείς, έχει περιγραφεί υπερπλασία των ούλων κατά τη χρόνια λήψη ΑΔΑ - CCBs.